

Bronchite aigue

Dr. Alioua Amina

Maitre assistante en pneumophtisiologie

Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine

Objectifs

- ❑ Définir une bronchite aiguë
- ❑ Connaître les germes en cause
- ❑ Savoir différencier une bronchite aiguë d'une pneumonie
- ❑ Traiter une bronchite aiguë

Plan

- ❑ Définition
- ❑ Epidémiologies
- ❑ Physiopathologie
- ❑ Agent causal
- ❑ Diagnostic positif
- ❑ Evolution
- ❑ Traitement
- ❑ Conclusion

Définition

- ❑ Inflammation aiguë des bronches et bronchioles (voies de conduction),
le plus souvent de nature infectieuse, sans atteinte du parenchyme
pulmonaire et notamment des alvéoles (surface d'échange)
- ❑ C'est une pathologie banale bénigne
- ❑ Diagnostic purement clinique

Epidémiologie

- ❑ Très fréquente (environ 10 millions de cas/an en France)
- ❑ Mode de survenue : épidémie saisonnière , automno-hivernale++.
- ❑ D'origine virale 90%
- ❑ L'évolution est bénigne
- ❑ Potentiel grave : âges extrêmes , comorbidités

Physiopathologie

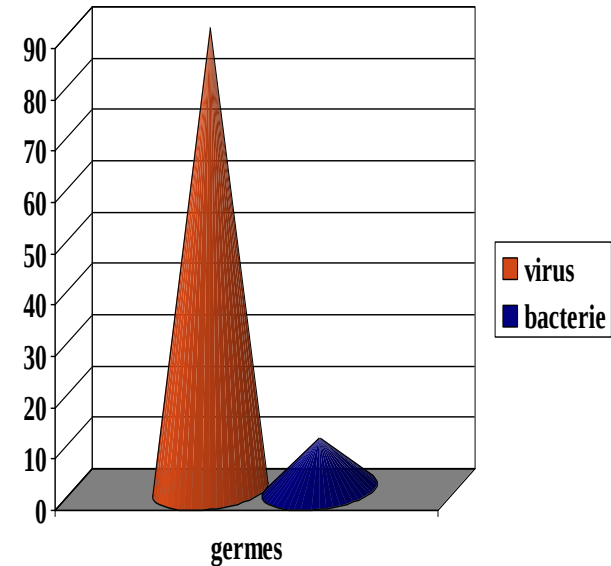
- ❑ Inflammation aigue de la muqueuse des VAI :
- Destructions épithéliales de la muqueuse bronchique ➡ Ulcération de la membrane basale :
 - exposition des terminaisons nerveuses + récepteurs bronchoconstricteurs ➡ hyperréactivité bronchique (Toux + bronchoconstriction)
- Hypersécrétion sero-muqueuse
- Œdème inflammatoire de la muqueuse avec infiltration de polynucléaires.
- ❑ Restitution ad integrum en 15jours

Agent causal

❑ Virus +++ 90%

- rhinovirus,
- influenza,
- para-influenza,
- Adénovirus
- virus respiratoire syncytial,
- métapneumovirus humain
- Corona virus

❑ Bactéries



Les virus

- Les virus

- Corona virus
- Rhino virus
- Adénovirus



Infections des voies aériennes
Supérieures associée à une bronchite

- Les virus influenza A,B
- Para influenza
- VRS



Bronchite prédominante

Les bactéries

- Les bactéries atypiques 5%
 - Mycoplasme pneumonie
 - Chlamydia pneumonie
 - Bordetella pertussis
- Les surinfections de bronchite virale Par d'autres bactéries est possible

Diagnostic positif

- ❑ Purement clinique ++

- ❑ Début :

- Coryza rhino-pharyngé,
- Pharyngite

- ❑ Puis signes d'irritation trachéo-bronchique :

- le maître symptôme c'est la toux ++
 - Quinteuse sèche initialement douloureuse
 - Brûlures rétro-sternales dessinant l'arbre bronchique

Diagnostic positif

- ❑ Contexte fébrile 38°C avec symptômes viraux (Céphalées, myalgies, arthralgies.)
- ❑ En quelques jours, phase humide en fonction de l'importance de l'inflammation trachéo-bronchique.
- ❑ L' auscultation:
 - Normal
 - Râles bronchiques bilatéraux. Parfois des sibilants.
 - Pas de signe de foyer parenchymateux +++
- ❑ Examen para clinique
 - Radio du thorax n'est pas nécessaire sauf si suspicion d'une pneumonie
 - Analyse bactériologique de l'expectoration est inutile

Diagnostic positif

La discordance entre les signes fonctionnels (plaintes) et physiques quasi absents (pas de polypnée, pas de foyer, aucun signe de gravité) ++++

Evolution

- ❑ Généralement simple, avec une régression en quelques jours des symptômes. **Guérison spontanée**
- ❑ Parfois toux quinteuse pendant quelques semaines « **post-virale** ».
- ❑ Si persistance ou aggravation des symptôme reconsidérer le diagnostic (bilan complémentaire)
- ❑ Parfois surinfection bactérienne
- ❑ L'évolution peut être grave chez les sujets fragilisés, porteurs d'une comorbidité

Diagnostic différentiel

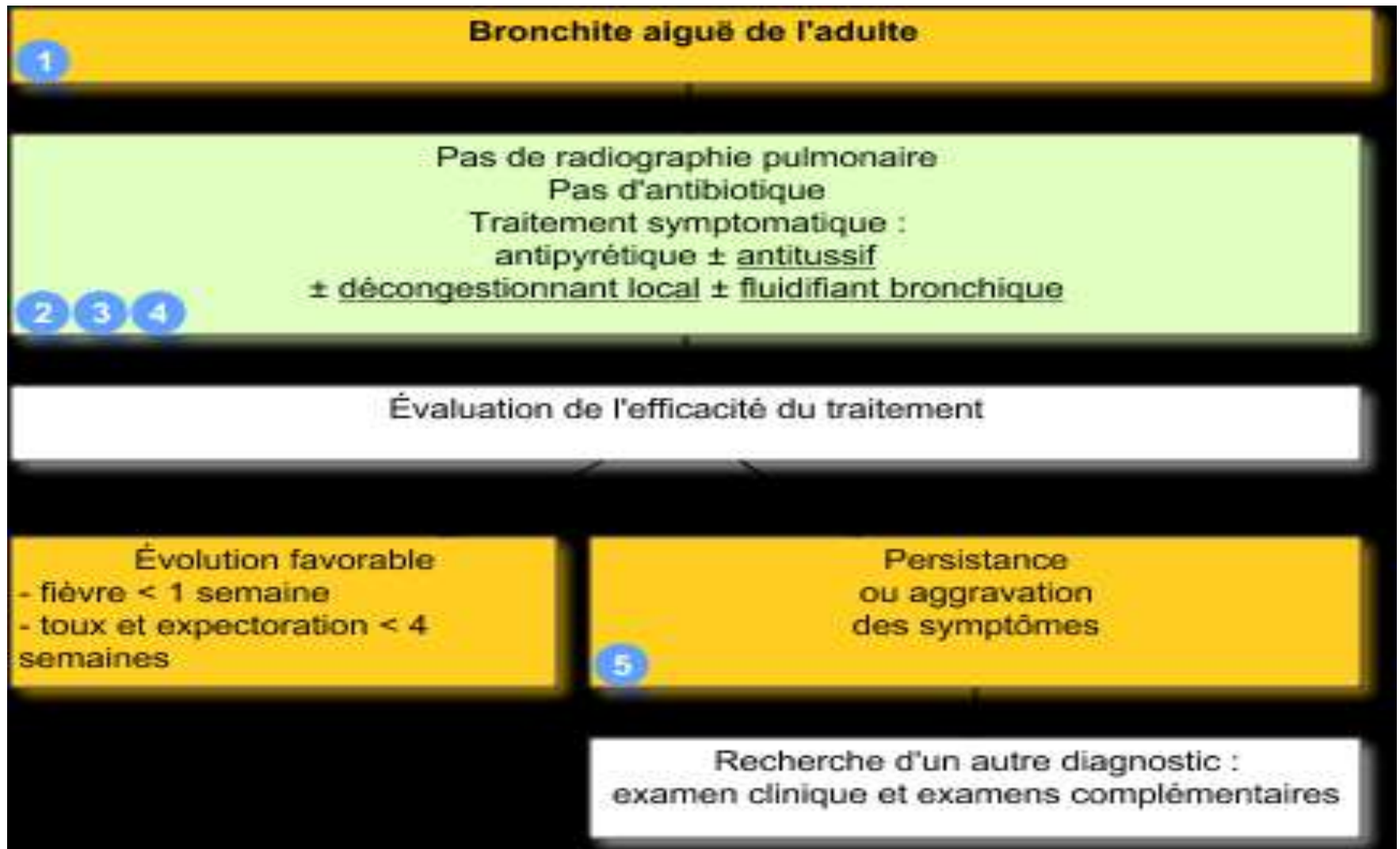
Pneumonie : La clinique permet habituellement de différencier la bronchite aiguë d'une pneumonie
Bronchite aiguë vs pneumonie.

Signes Suggestifs de bronchite :	Signe suggestifs de pneumonie :
-fièvre en général peu élevé -brulure retro sternale -toux parfois précédée d'infection des voies respiratoire hautes -auscultation normale ou râles bronchiques diffus.	-fièvre > 37,8 °C -Tachycardie > 100/min -Polypnée >> 25/min -douleur thoracique -absence d'infection des voies respiratoires hautes -signes auscultatoires en foyer (râles crépitants) -Impression globale de gravité.

Traitement

- ❑ Symptomatique :antipyrétique, antitussif, antalgique
- ❑ Abstention de prescrire les antibiothérapie est la règle chez l'adulte sain
- ❑ Antibiothérapie si:
 - Toux persistante et expectoration purulente >7jrs
 - Râles bronchiques diffus
 - Et tabagisme.

Prise en charge



Conclusion

- ❑ La bronchite aiguë est virale dans $> 90\%$ des cas
- ❑ Diagnostiquer la bronchite aiguë principalement par la clinique
- ❑ Un télé thorax et/ou d'autres examens uniquement en cas de manifestations graves de la maladie.
- ❑ Traiter la plupart des patients seulement pour soulager les symptômes.

Merci de votre attention